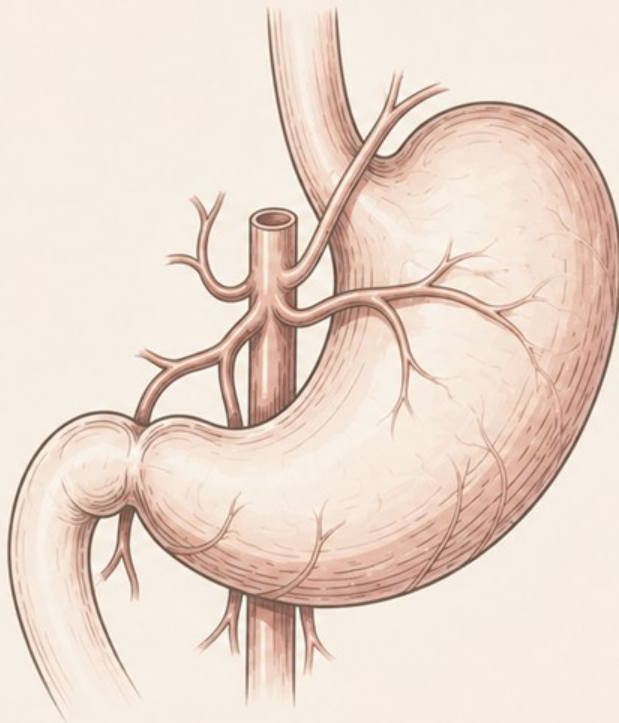


Chapitre 9 — Estomac

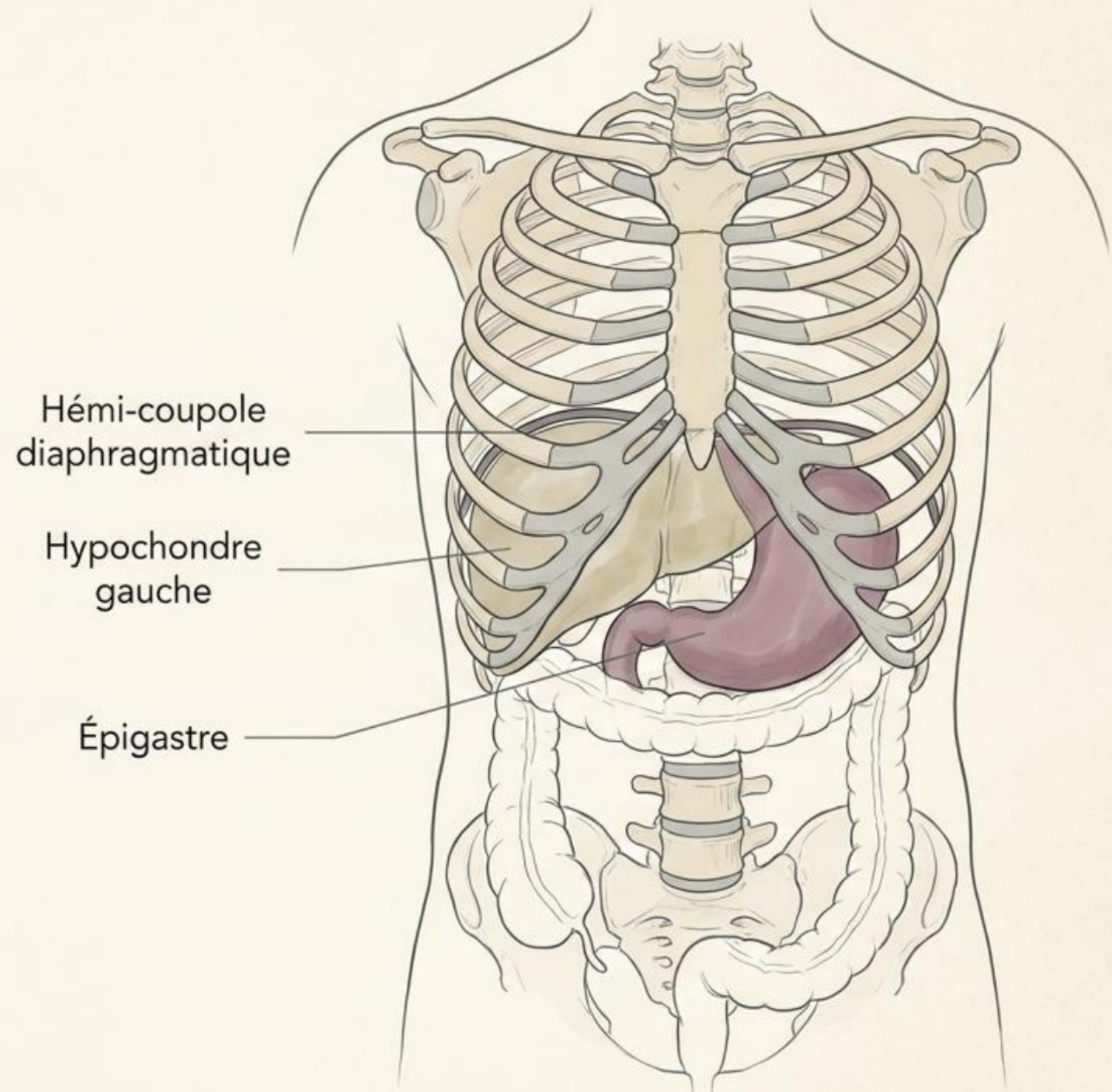
Anatomie, Physiologie et Réflexologie
Occipito-Podale (ROP)



Situation Topographique

- Loge : Hypochondre gauche et épigastre.
- Axe vertébral : S'étend de Th11 à L2.
- Protection : Sous l'hémi-coupole diaphragmatique gauche, gril costal (5e à 10e côte).

Rapport postérieur : Bourse omentale.
Organe intra-péritonéal.



Morphologie et Segments Gastriques

Sphincter inférieur œsophagien (SIO)
(Th10 - Physiologique)

Cardia & Incisure cardiale
(Angle de His)

Petite courbure

Grosse tubérosité / Fundus
(Poche d'air radio-transparente)

Corps gastrique
(Zone de brassage)

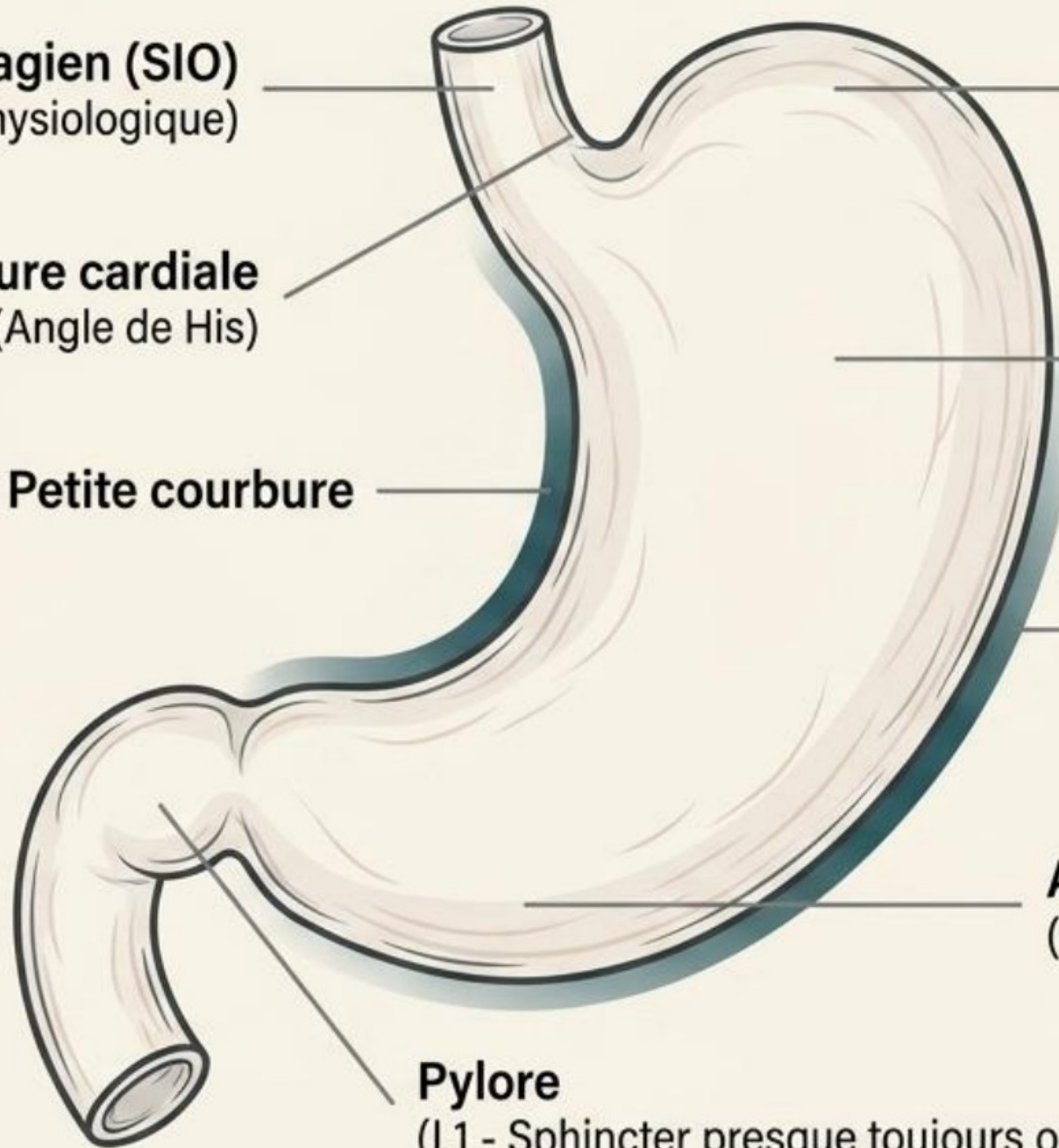
Grande courbure
(Bord latéral, ombilic L3)

Antre pylorique
(Réservoir de vidange)

Pylore
(L1 - Sphincter presque toujours ouvert, filtre à 3mm)

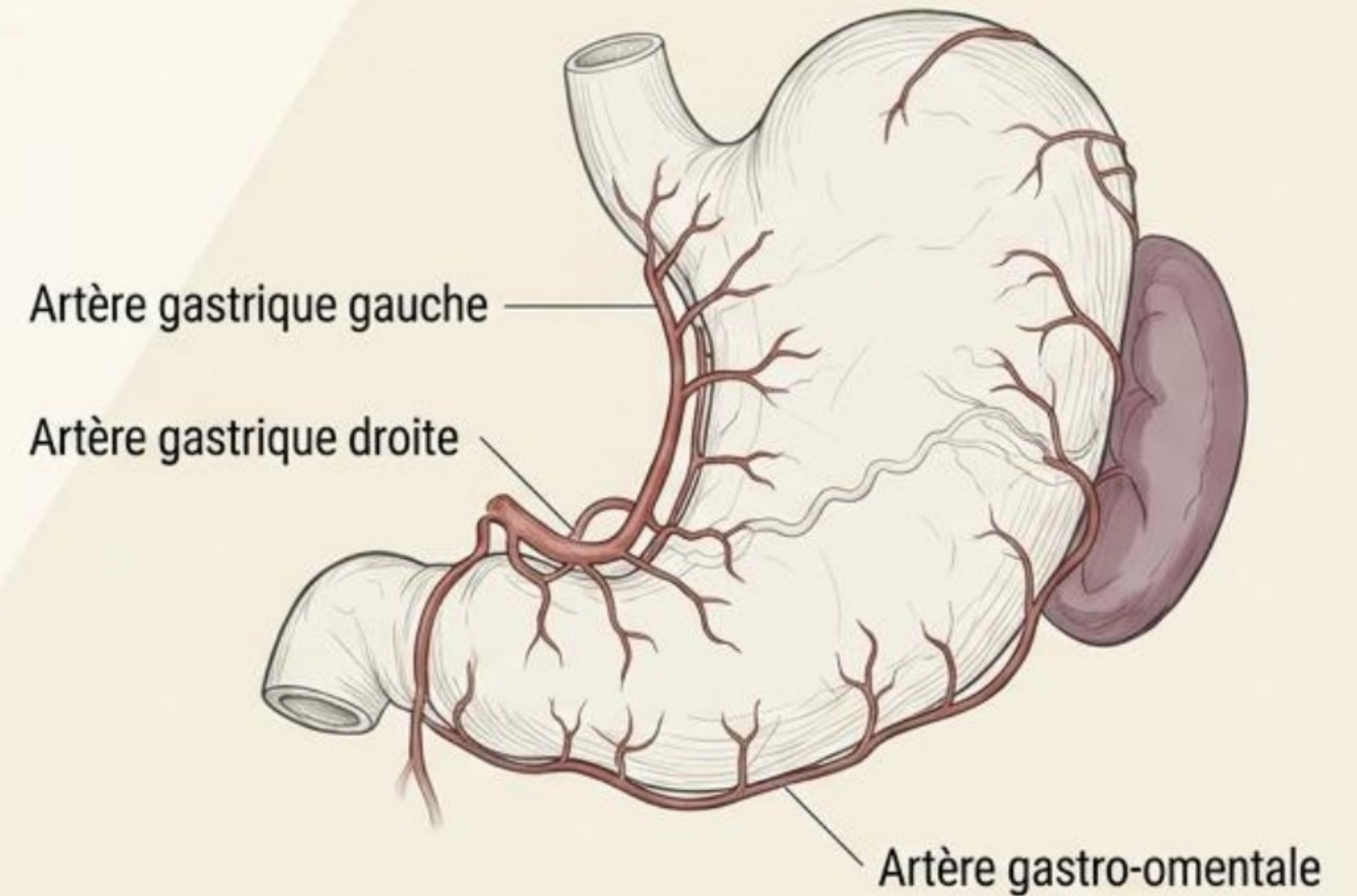
Intérêt en ROP

Focus sur la Petite courbure.
Richement innervée par le
parasymphatique et lieu de
fixations/ulcérations majeures.



Vascularisation et la Petite Courbure

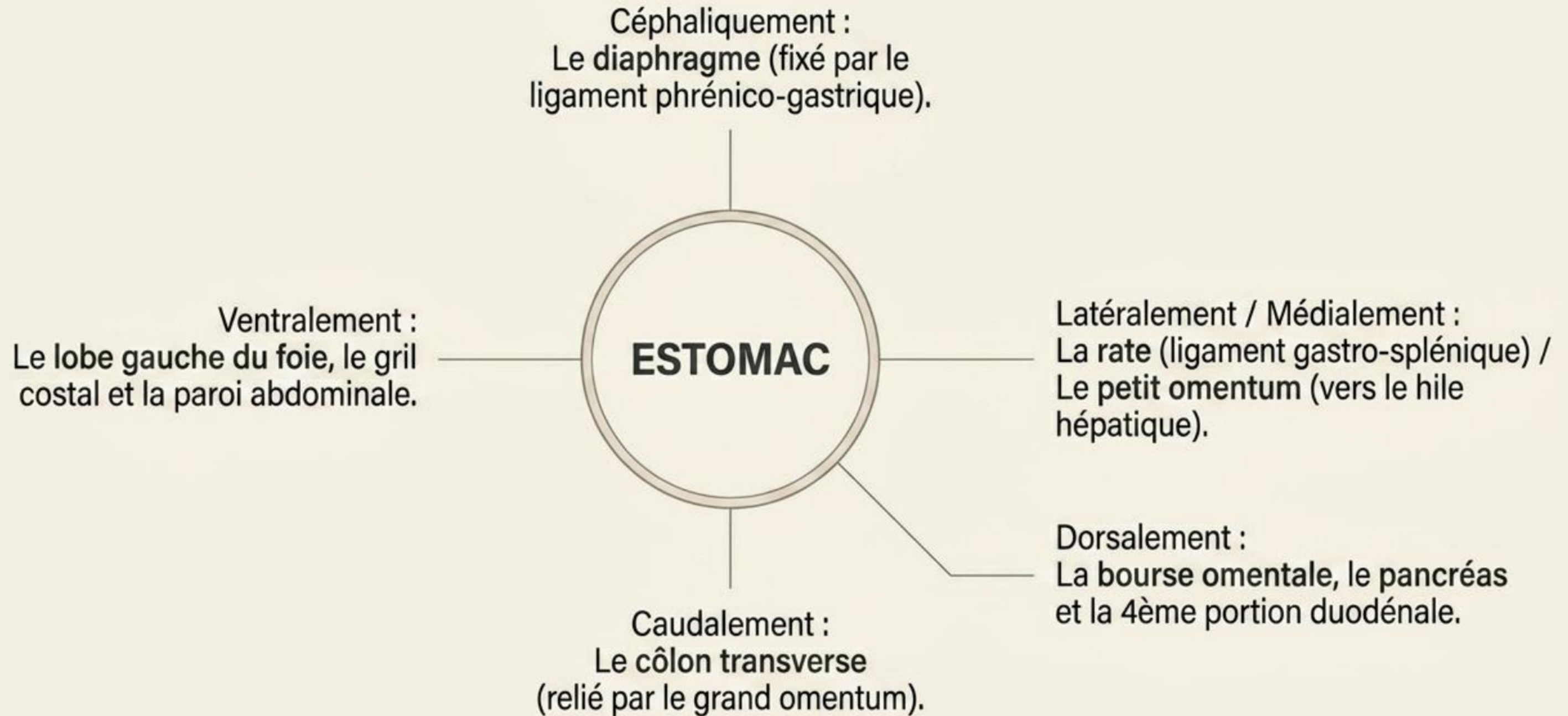
Tronc Coeliaque (Th12) → Artère splénique,
Artère gastrique gauche,
Artère gastrique droite.



Intérêt Pratique en ROP

La petite courbure exige une attention prioritaire. Profondément située et accolée à la colonne (Th10-L1), elle concentre une riche vascularisation et innervation parasymphatique. C'est le lieu privilégié des fixations mécaniques et des ulcérations gastriques.

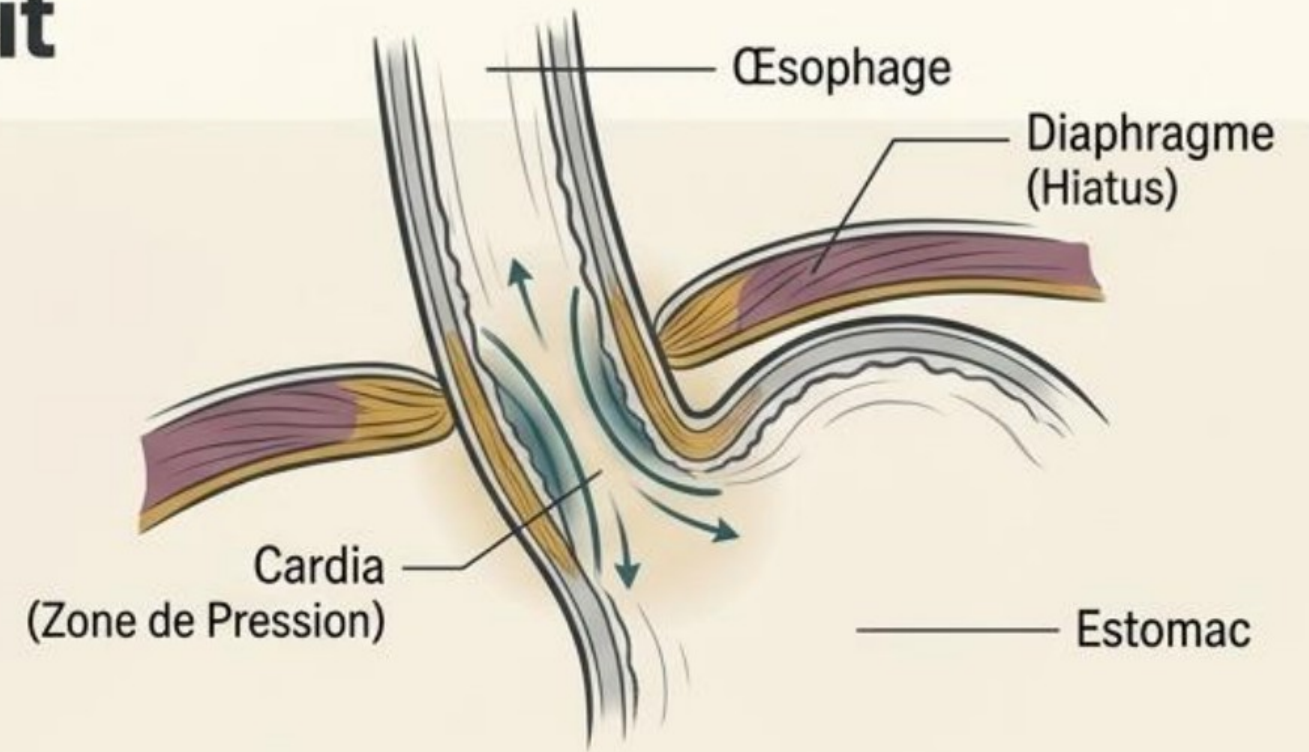
Les Rapports Anatomiques



Les Sphincters : Gardiens du Transit

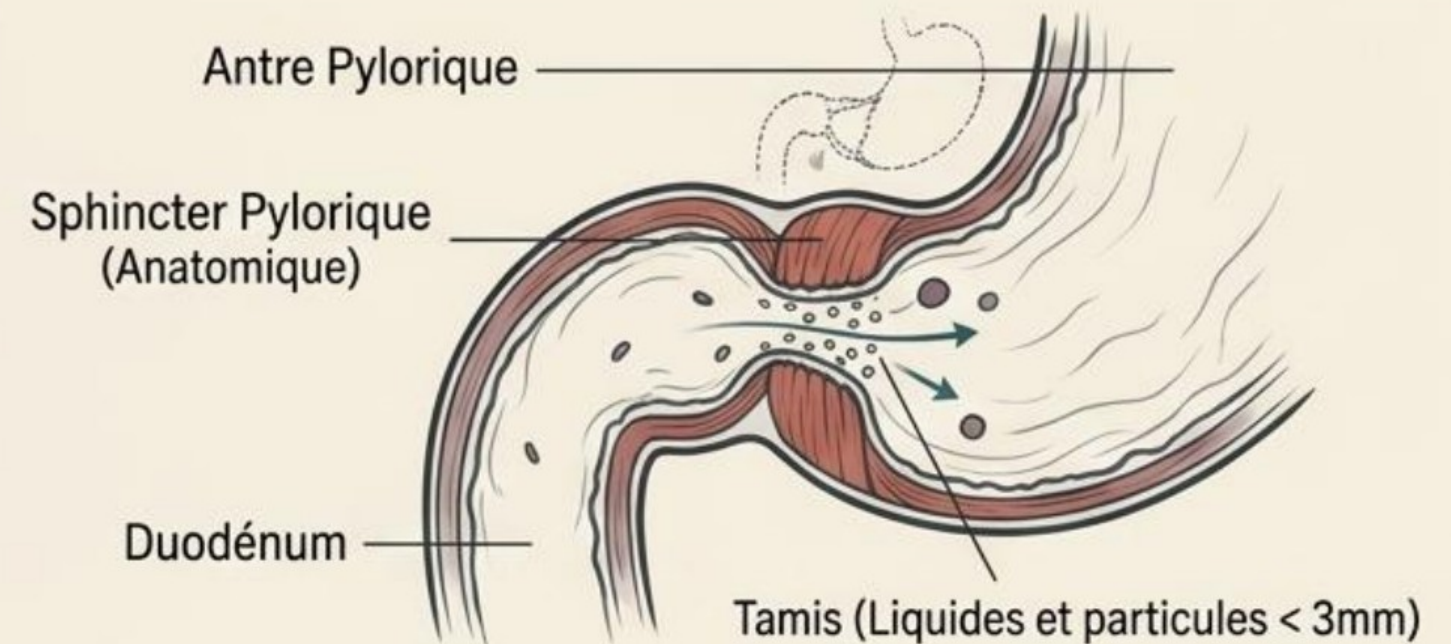
Le SIO - Sphincter Inférieur Œsophagien

- Entité physiologique (non anatomique).
- Situé à hauteur de Th10 (traversée du hiatus diaphragmatique).
- Contrôle l'entrée par un différentiel de pression.

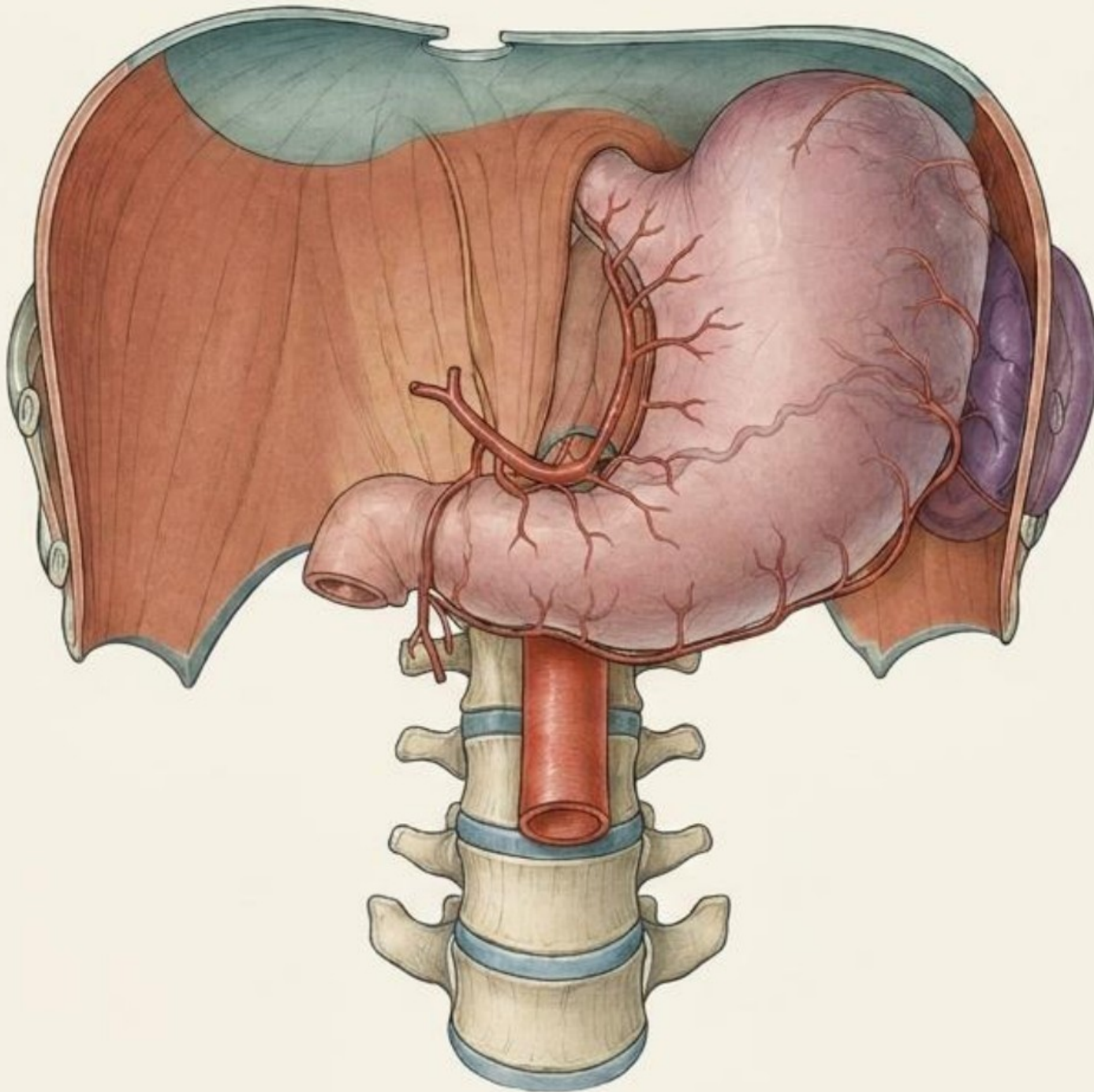


Le Pylore

- V véritable sphincter anatomique.
- Situé à hauteur de L1.
- Se comporte comme un tamis : laisse passer les liquides et les particules solides < 3mm.
- Déplacement vers la droite en cas de stress.



Vascularisation : L'Origine Cœliaque



Aorte Abdominale (Hauteur Th12)

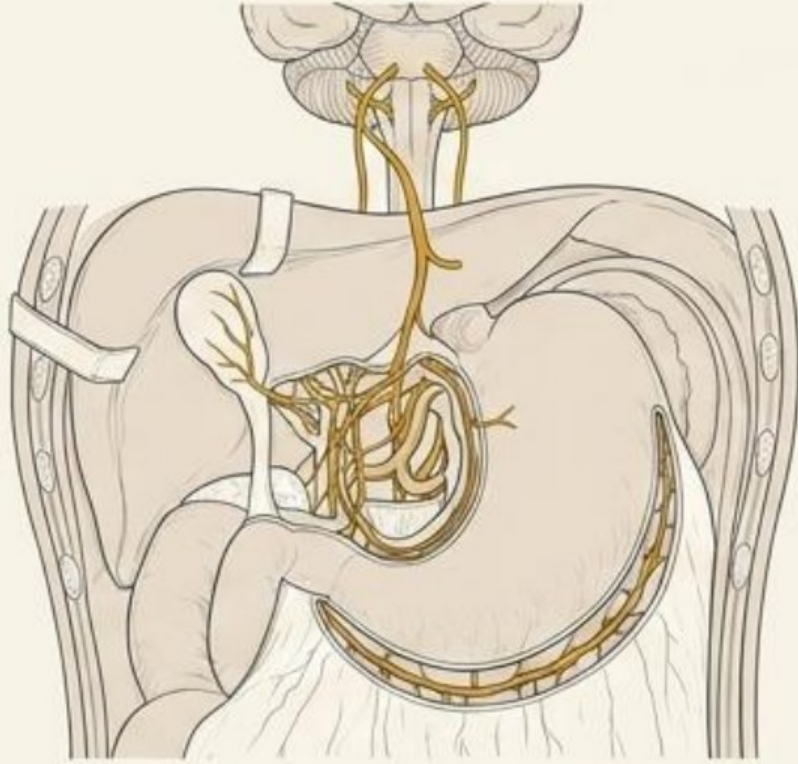
└ Tronc Cœliaque se divise en trois branches :

- └ 1. Artère splénique
- └ 2. Artère gastrique gauche
- └ 3. Artère hépatique commune

└ donnant l'artère hépatique propre, puis la gastrique droite

Les branches collatérales forment les puissants cercles artériels de la petite et de la grande courbure.

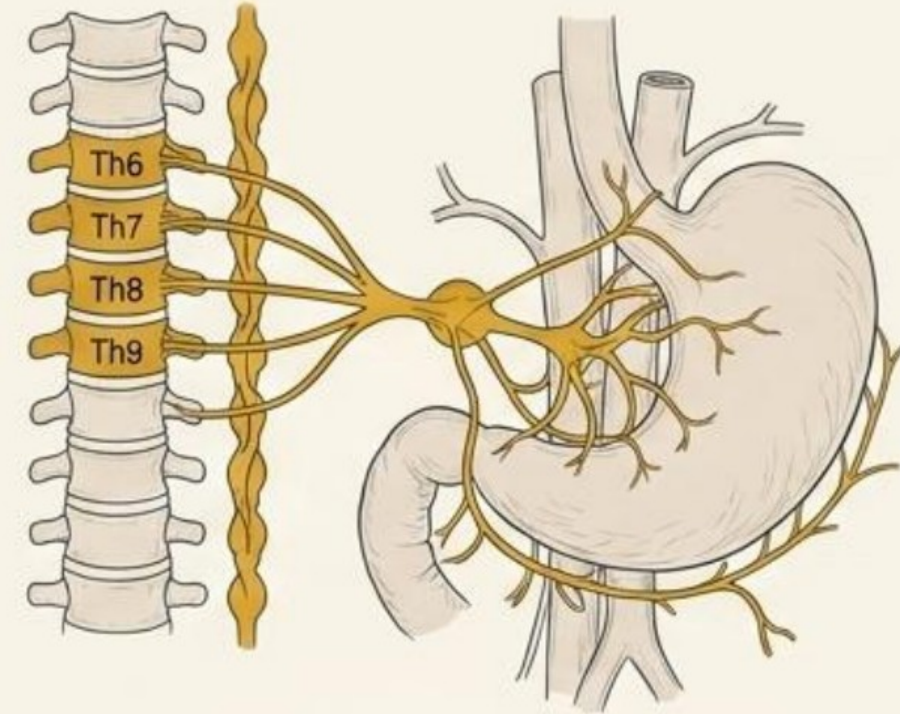
La Balance Neuro-Végétative



Parasympathique Les Nerfs Vagues (X).

Rôle essentiel sur la fonction mécanique et neuro-hormonale.

Action : Augmente la sécrétion (gastrine, HCl, pepsine) et accélère l'évacuation gastrique.



Sympathique Grand Nerf Splanchnique (Th6-Th9).

Action antagoniste. Inhibe la motilité et les sécrétions.

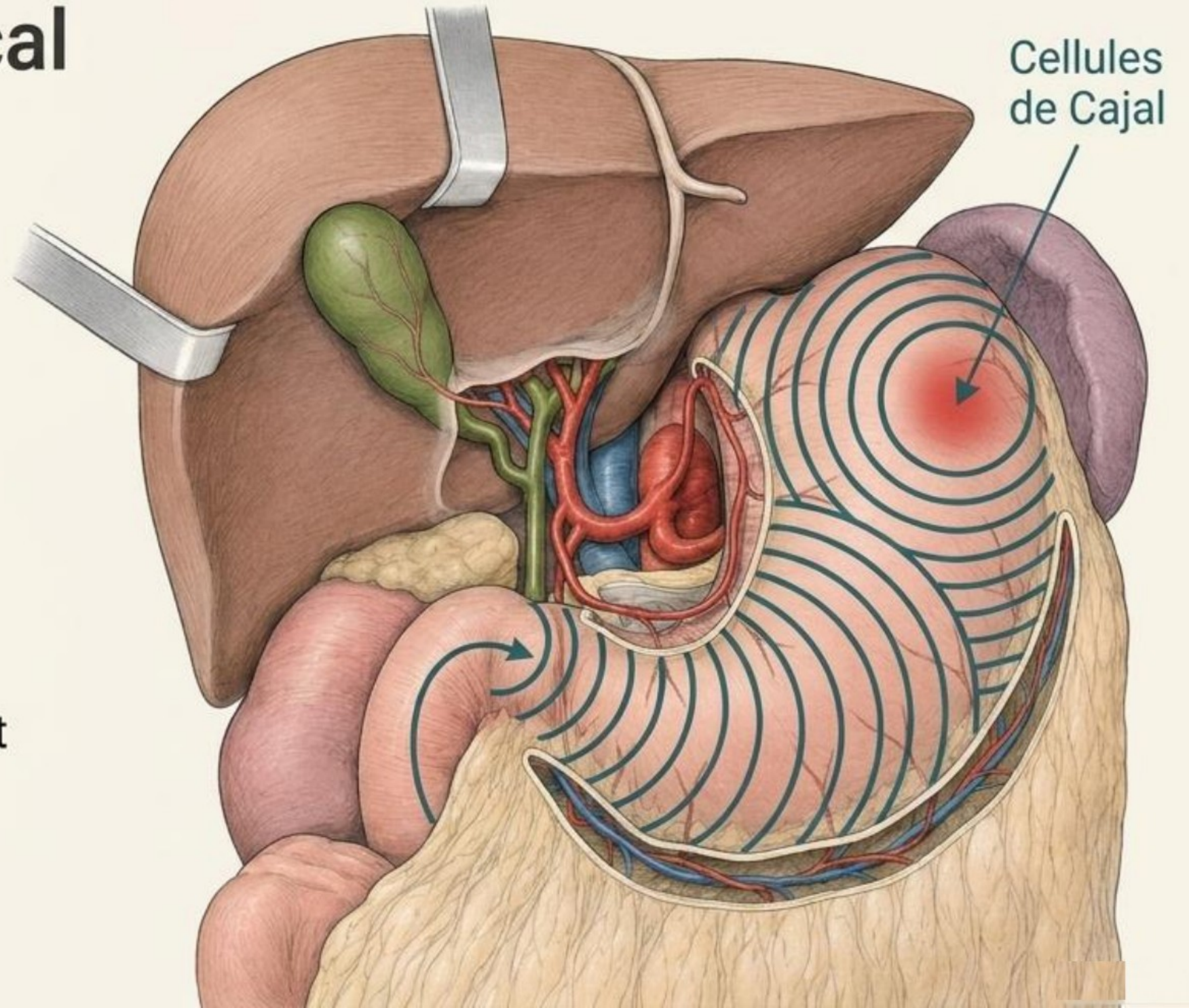
Focus ROP : Priorité au nerf

Une dysfonction de l'estomac crée une tension musculaire viscéro-somatique réactive au niveau de la vertèbre Th6.

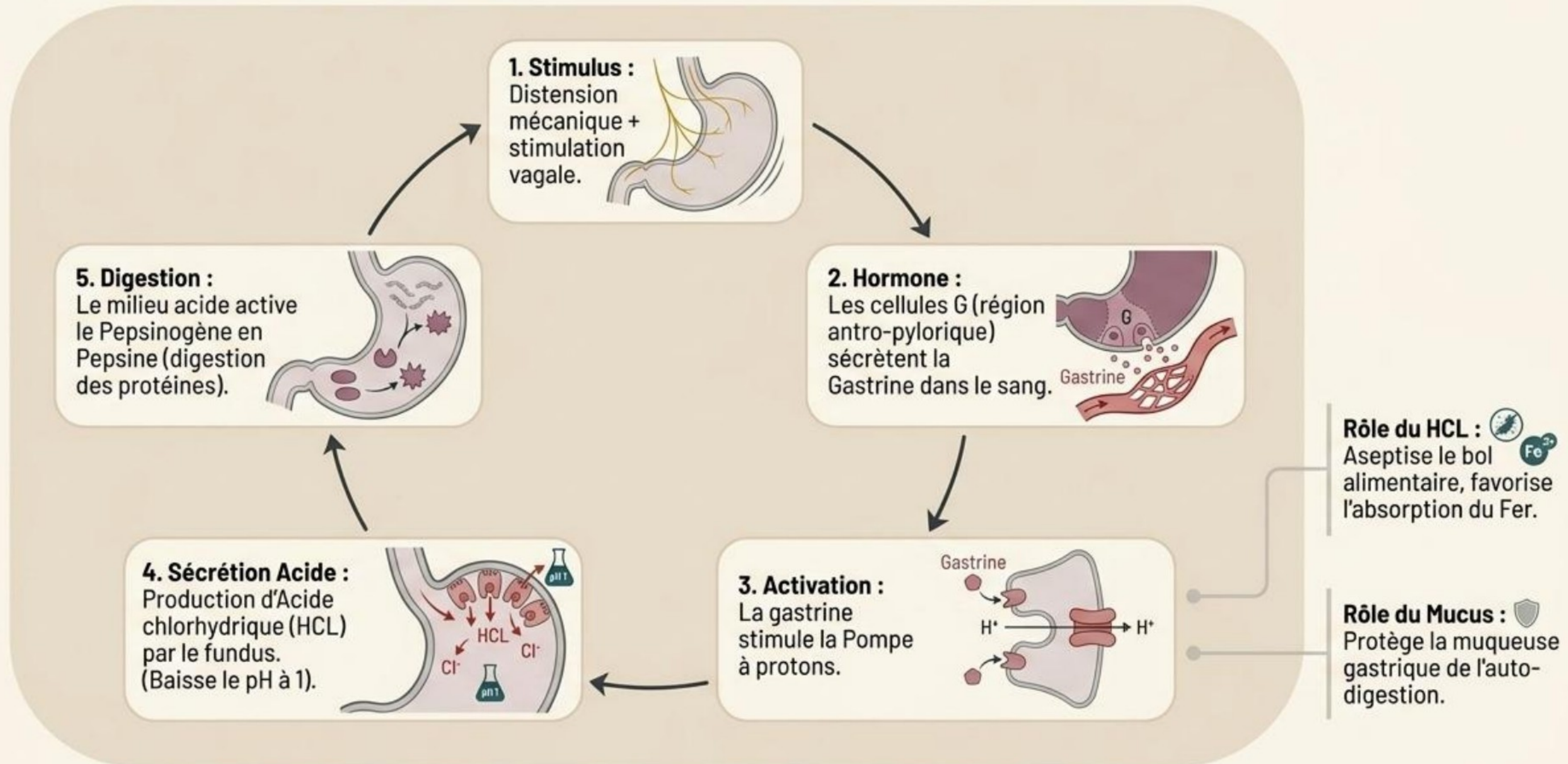
Le Rythme Gastrique : Le Pacemaker Stomacal

Un centre nerveux propre rythmant les contractions stomacales de base.

- Ondes électriques déclenchées par le remplissage et la gastrine.
- Rythme régulier : 10 à 20 secondes.
- Propagation : Vers l'antrum et le pylore.
- Exception : Le fundus (occupé par la poche d'air) ne reçoit pas d'aliments et ne se contracte pas.



La Cascade Neuro-Hormonale (1,5 L de sucs/24h)



Matrice de la Digestion Chimico-Hormonale (1,5L / 24h)

Substance	Source	Déclencheur/État	Action
Acide chlorhydrique (HCl)	Sécrété par le fundus via pompe à protons	pH=1 (estomac vide)	Aseptise le bol alimentaire, favorise l'absorption du fer.
Mucus	Muqueuse gastrique	Permanent	Protège la muqueuse de l'acidité et facilite le glissement.
Pepsine (via Pepsinogène)	Muqueuse gastrique	Activé par milieu acide	Digestion enzymatique des protéines.
Gastrine	Cellules G (Antre)	Stimulée par le nerf vague	Augmente la sécrétion de HCl et accélère le pacemaker stomacal.

La Vidange Gastrique : Le Tamis Pylorique

Phase liquidienne

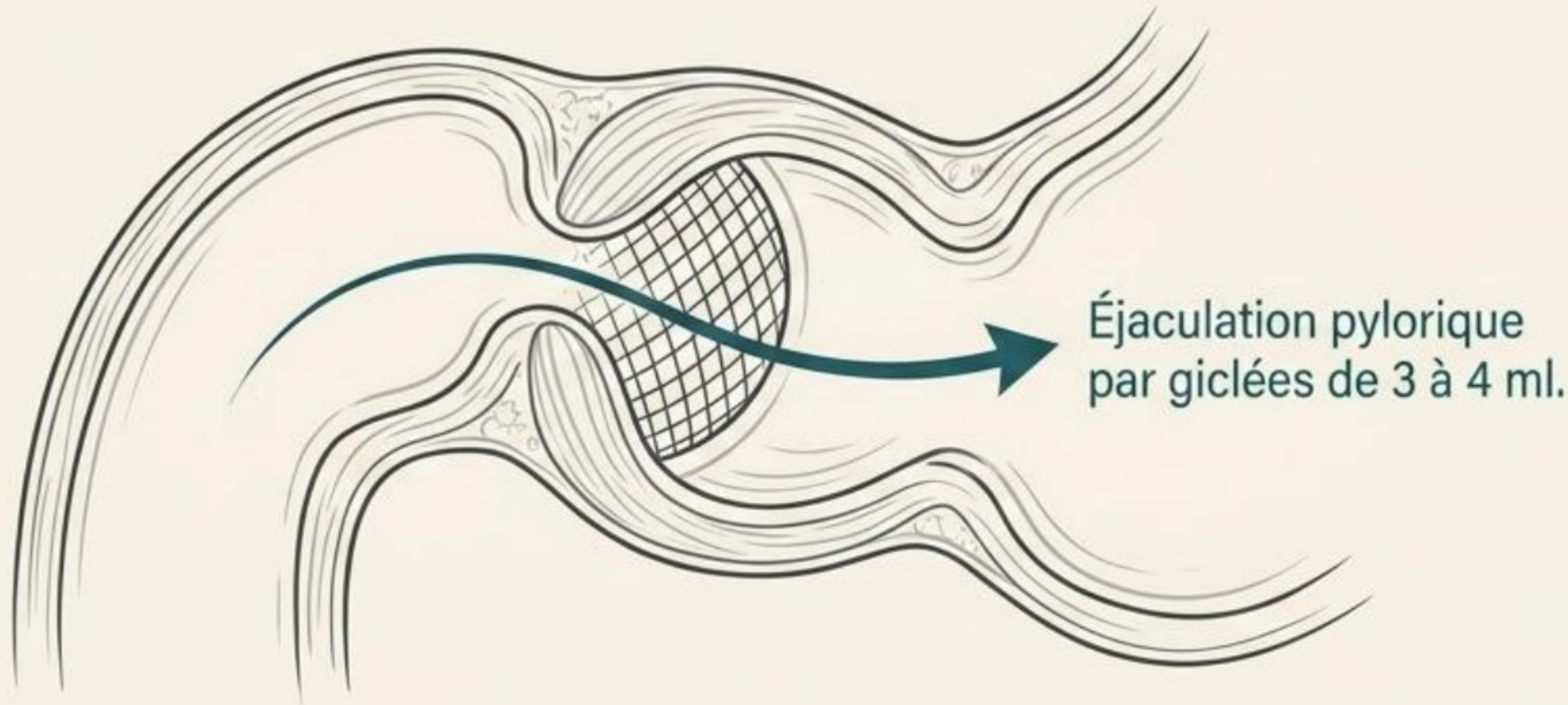
< 30 mn

Phase solide digestive

Durée variable selon le bolus

Phase solide indigestive

Mouvement rétrograde.
Particules réduites à < 3mm

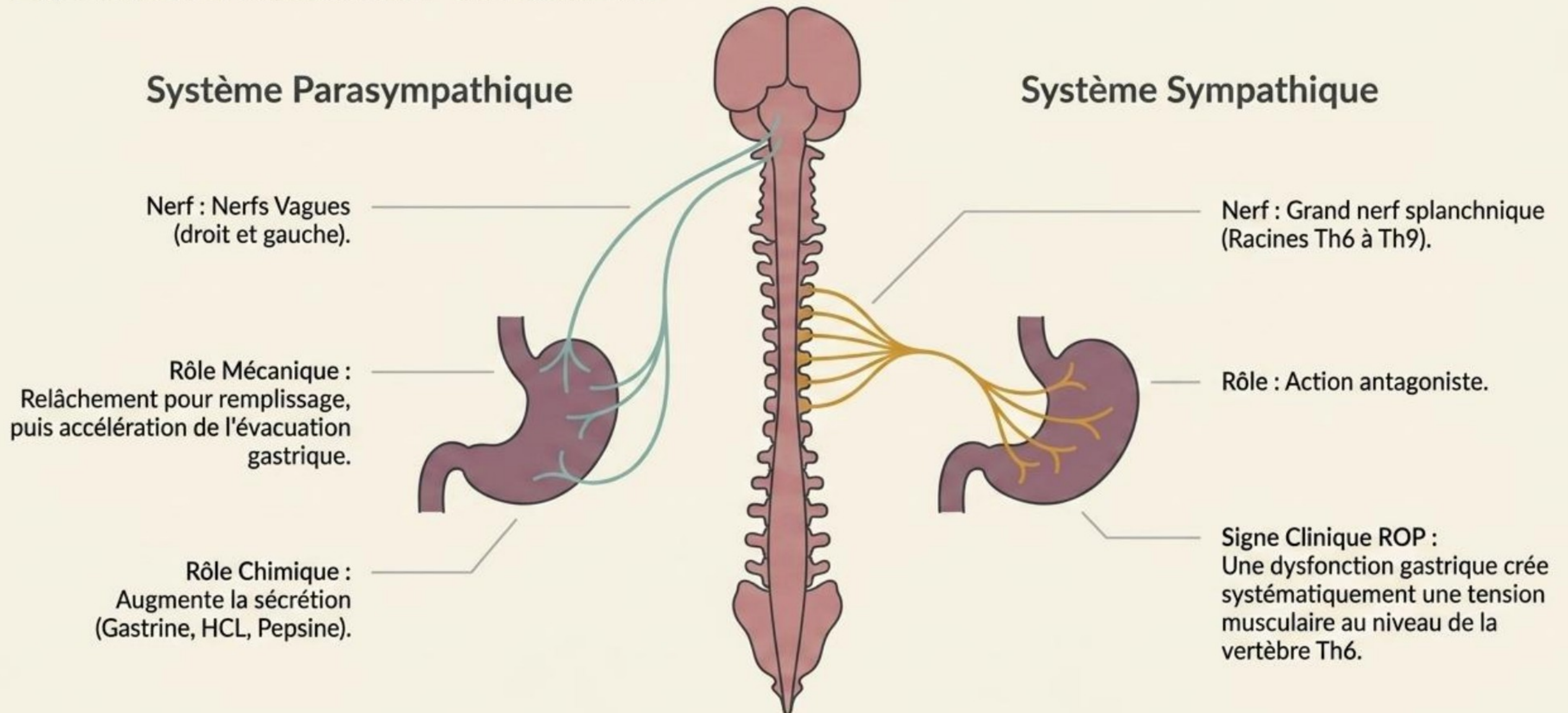


Régulation Hormonale

Régulée par la Sécrétine (sécritée par le duodénum) pour neutraliser l'acidité et inhiber la contraction antrale en fonction des capacités d'absorption intestinales.

La Balance Neuro-Végétative

Le principe ROP fondamental : "Priorité au nerf"



Matrice des Pathologies Fonctionnelles

Hypochlorhydrie et Fermentation : le dénominateur commun des dysfonctions.

Pathologie	Mécanisme	Symptomatologie	Étiologie / Notes
Gastralgie simple	Liée au stress.	Digestion lente, ballonnements, aigreurs, dorsalgie.	-
Gastro-parésie (Estomac atone)	Déficit vagal, mauvaise vidange pylorique, création d'un biofilm bactérien.	Pesanteur abdominale, vêtements serrés insupportables, estomac toujours "plein".	-
Gastrite (Inflammatoire)	Œdème, nécrose épithéliale.	-	Éthylisme, AINS, Helicobacter pylori, avitaminose.
Pylorospasme	Défaut de relâchement (immaturité vagale).	Vomissements abondants (nourrissons 2 sem. post-naissance).	Cible: Nourrissons.

Carences Martiales : Une hypochlorhydrie compromet l'assimilation du fer (anémie ferriprive). Le traitement ROP vise l'estomac, le foie et la rate.



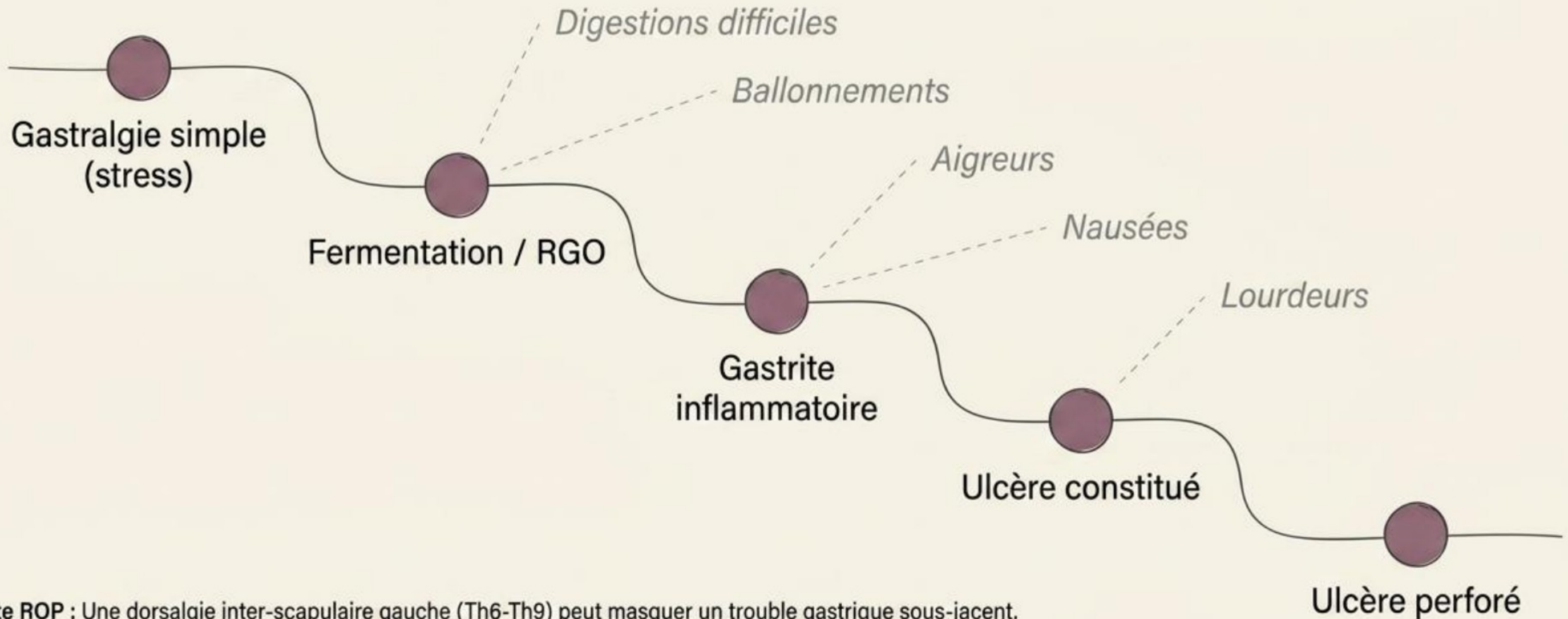
Drapeaux Rouges : Diagnostics d'Exclusion

Les troubles fonctionnels imitent souvent les débuts d'une pathologie grave.
Tout symptôme suivant requiert une exclusion médicale immédiate.

- Présence de ganglion de Troisier (rétro-claviculaire gauche).
- Amaigrissement rapide inexpliqué.
- Fièvre et douleurs thoraco-abdominales profondes.
- Hématémèse : Vomissement de sang rouge vif.
- Méléna : Selles goudronneuses / sang noir digéré (signe d'ulcère perforé).
- Douleurs nocturnes (ou "au chant du coq").

Le Continuum Pathologique Gastrique

Principe clinique : La douleur n'est pas proportionnelle à la gravité de l'atteinte tissulaire.
Toutes les dysfonctions se caractérisent initialement par un manque d'acidité favorisant la fermentation.



Note ROP : Une dorsalgie inter-scapulaire gauche (Th6-Th9) peut masquer un trouble gastrique sous-jacent.

Focus Clinique ROP : Trois Dysfonctions Clés



Gastro-parésie (Estomac atone)

Déficit du nerf vague →
stagnation prolongée → biofilm
et pullulation bactérienne.
Sensation de pesanteur,
intolérance aux ceintures
serrées.



Carence Martiale (Anémie)

L'hypochlorhydrie compromet
l'ionisation et l'assimilation du
fer alimentaire.

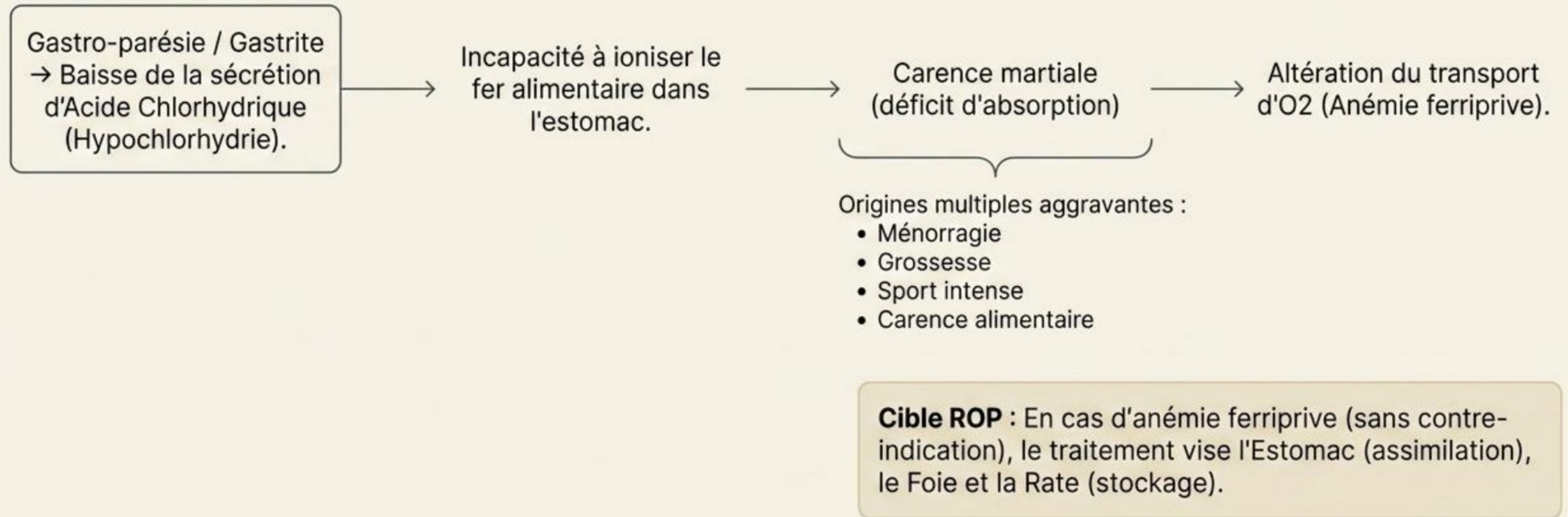
*Stratégie ROP : Cibler l'Estomac
(assimilation) + Foie/Rate
(stockage).*



Pylorospasme du Nourrisson

Incapacité des fibres musculaires
à se relâcher (immaturité vagale).
Apparaît ~2 semaines après la
naissance (vomissements
abondants, faim constante). À
différencier de la sténose
chirurgicale.

Cascade Pathologique : L'Hypochlorhydrie et le Fer



Cartographie ROP : Cibles Réflexes

Zone 1 : Syndrome Général d'Adaptation

- Chaîne ganglionnaire latéro-vertébrale (Th6-Th9)
- Diaphragme et ses piliers
- Plexus prévertébral

Zone 2 : Syndrome Loco-Régional

- SIO (confondu avec hiatus œsophagien)
- Petite courbure (ligne interne)
- Grande courbure (ligne externe)
- Pylore (bord médian plantaire, prédominant à droite)

Zone 3 : Balance du Système Limbique

Technique d'écoute-induction : Un pouce sur la zone estomac, un pouce sur la zone cerveau limbique.

Relations viscéro-émotionnelles – Estomac

Grille de lecture ROP : valorisation et place sociale



Dans la lecture viscéro-émotionnelle ROP, l'estomac est associé au « moi social » : reconnaissance, valorisation et place occupée dans le groupe. Selon l'histoire du patient, la relation à la figure paternelle peut également être explorée.



Polarité d'hypervalorisation

- Surestimation de soi, besoin important de reconnaissance
- Mauvaise tolérance à la critique, colère impulsive
- Recherche de réussite, de séduction ou de démonstration
- Peur de l'échec, fuite en avant

« Pour qui il se prend ? »



Polarité d'hypovalorisation

- Manque de confiance, repli, dépréciation de soi
- Frustrations difficilement exprimées
- Rancœurs non verbalisées
- Vécu répété de subordination



Ces associations constituent une grille clinique et symbolique propre à la ROP ; elles ne constituent ni un profil psychologique diagnostique ni un mécanisme physiopathologique démontré.

Tableau de Bord Thérapeutique ROP



Points d'Entrée Somatiques & Limbiques

- Axe Vertébral : Th6 à Th9 (Chaîne latéro-vertébrale gauche).
- Écoute-induction : Balance Cerveau Limbique ↔ Estomac.
- Mécanique : Diaphragme et ses piliers. Plexus prévertébral.

Cartographie Plantaire (Estomac)

- SIO : Confondu avec le hiatus œsophagien.
- Petite/Grande courbure : Lignes courbes plantaires.
- Pylore : Bord médian plantaire (souvent plus marqué à droite).

Conseils Diététiques

- À éviter : Lait (soulagement court, dommage long terme), eau trop froide (spasme), alcool, sucre pur.
- À privilégier : Un verre d'eau avec du jus de citron pour soutenir le processus digestif.